

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Measure of Body Apperception — Medida de Percepción del Cuerpo (MBA)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

ADVERTENCIA DE VERIFICACIÓN INICIAL (2026-08-10): el instrumento original en inglés (Carver et al., 1998) tiene 10 ítems, de los cuales 8 se puntúan (ítems 1, 3, 6, 8 = subescala de apariencia; ítems 2, 4, 7, 9 = subescala de integridad corporal) y 2 son ítems de relleno no puntuados (ítems 5 y 10, sobre control de dieta). El Protocolo.pdf de este acervo (traducción al español) contiene únicamente 8 ítems, que se corresponden exactamente con los 8 ítems puntuados del original (omite los 2 ítems de relleno no puntuados). Es decir: el protocolo local está funcionalmente completo para fines de puntuación, pero NO reproduce la experiencia de administración íntegra de 10 ítems del instrumento original. Ver sección 7 para el detalle.

Familia / sigla	MBA
Nombre completo	Measure of Body Apperception — Medida de Percepción (o Apreciación) del Cuerpo
Versión / edición	Traducción al español de los 8 ítems puntuados del instrumento original; no se identificó en esta búsqueda una publicación formal de adaptación/validación en español con nombre de autores ni año — no verificado.
Idioma	Español (traducción; origen y validación de la traducción no verificados).
Autores (original)	Carver, C. S., Pozo-Kaderman, C., Price, A. A., Noriega, V., Harris, S. D., Derhagopian, R. P., Robinson, D. S., & Moffatt, F. L. Jr.
Año (original)	1998 (Psychosomatic Medicine); ver también Petronis, Carver, Antoni & Weiss (2003) para una réplica parcial.
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Imagen corporal; autoestima contingente a la apariencia; integridad corporal; ajuste psicosocial a enfermedad/cirugía.
Pregunta clínica que responde	¿En qué medida el sentido de valor personal de la persona depende de su apariencia física o de la integridad de su cuerpo? (relevante ante diagnósticos médicos, cirugías o enfermedades que amenazan la imagen corporal, p. ej. cáncer de mama).
Población	Desarrollado y usado originalmente con mujeres en etapa temprana de cáncer de mama (Carver et al., 1998; Petronis et al., 2003); no se limita conceptualmente a esa

	población pero no se verificaron baremos para población general en esta búsqueda.
Contexto de aplicación	Investigación y clínica de salud (psico-oncología, ajuste a enfermedad médica o cirugía); potencialmente aplicable a otros contextos de imagen corporal, sin baremos verificados fuera de la población oncológica.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual.
Número de ítems	10 ítems en el instrumento original en inglés (8 puntuados + 2 de relleno no puntuados). El Protocolo.pdf de este acervo contiene 8 ítems (verificado por conteo directo), coincidentes exactamente con los 8 ítems puntuados del original; faltan los 2 ítems de relleno (no afecta la puntuación, sí la fidelidad de administración del instrumento completo tal como fue publicado).
Periodo temporal de referencia	No especifica periodo temporal explícito (formulación en presente/general, según fuente oficial del autor).
Formato de respuesta	Escala de acuerdo de 4 puntos: 1 = Estoy en desacuerdo - completamente ... 4 = Estoy de acuerdo - completamente (numeración de la traducción local, orden ascendente de acuerdo; ver fuente oficial en inglés para la redacción original: 4 = agree a lot ... 1 = disagree a lot, orden numérico invertido respecto a la traducción local — confirmar la dirección exacta contra el Protocolo.pdf antes de puntuar).
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 5 minutos).
Regla de puntuación	Subescala Apariencia = suma de ítems 1, 3, 6, 8 de la numeración original (equivalentes a los ítems 1, 3, 5 y 7 en la numeración de 8 ítems del protocolo local, tras excluir los 2 de relleno). Subescala Integridad corporal = suma de ítems 2, 4, 7, 9 originales (equivalentes a los ítems 2, 4, 6 y 8 del protocolo local). IMPORTANTE: antes de puntuar el protocolo local hay que remapear manualmente su numeración 1-8 a la numeración original 1-10, siguiendo la correspondencia indicada en esta ficha, para evitar errores de asignación de subescala.

Ítems invertidos	No verificado en las fuentes consultadas.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	4-16 por subescala (4 ítems x 1-4 puntos cada una), asumiendo escala de 4 puntos sin ítems invertidos — no verificado con certeza porque la fuente oficial no publica rango ni baremos explícitos.
Puntos de corte	No se localizaron puntos de corte clínicos de consenso — no verificado, no usar para decisiones diagnósticas.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (copia directa del PDF ya presente en el acervo del proyecto, Otros/output/pdf/MBA_Scale.pdf; verificado ítem por ítem contra la versión oficial en inglés publicada por C. S. Carver, University of Miami — coincide con los 8 ítems puntuados). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Ficha generada a partir de fuente primaria oficial del autor (página institucional de C. S. Carver, University of Miami, leída íntegramente); se detectó y documentó que el protocolo local omite los 2 ítems de relleno no puntuados del instrumento original. Requiere revisión humana antes de uso clínico, en especial la correspondencia de numeración para la puntuación por subescalas.
Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: Inversión o dependencia de la propia imagen corporal como fuente del sentido de valor personal (self-worth), en dos vertientes: dependencia de la apariencia física ante otros, y dependencia de la sensación de integridad/intactitud corporal.

Finalidad

Evaluar cuánto depende la autoestima de una persona de su apariencia física o de la integridad de su cuerpo; especialmente relevante en el ajuste psicológico a condiciones médicas o cirugías que alteran la apariencia o integridad corporal.

Usos apropiados

Investigación y clínica de ajuste psicosocial a enfermedad médica, cirugía o condición que amenace la imagen corporal (uso original: cáncer de mama en etapa temprana).

Complemento a otras medidas de imagen corporal (p. ej. BSQ, ya presente en este acervo) para diferenciar insatisfacción corporal general de dependencia de la autoestima respecto al cuerpo.

Usos NO apropiados

Diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria o de la imagen corporal por sí solo: es una medida de dependencia de la autoestima al cuerpo, no un instrumento diagnóstico.

Generalización directa de baremos oncológicos a población general sin advertencia, dado que no se verificaron baremos para población general en esta búsqueda.

Puntuar sin resolver primero la correspondencia de numeración entre el protocolo local (8 ítems) y la estructura original de 10 ítems / 2 subescalas (ver campo 'Regla de puntuación').

9. Adaptación cultural y norma local

No se localizó, en esta búsqueda, una publicación formal de adaptación/validación al español con muestra, fiabilidad y baremos propios — no verificado. El texto en español presente en este acervo parece ser una traducción de uso interno/clínico, sin ficha de validación identificada.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Instrumento breve, desarrollado y validado principalmente en mujeres con cáncer de mama; su aplicabilidad y baremos en otras poblaciones no están verificados en esta búsqueda.

No sustituye una evaluación clínica de imagen corporal ni el juicio clínico profesional.

La traducción española local no cuenta, hasta donde se verificó, con estudio de fiabilidad/validez propio — usar con cautela y preferentemente como apoyo cualitativo hasta confirmar sus propiedades psicométricas en español.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El instrumento está publicado por C. S. Carver y colaboradores (University of Miami) en su página institucional de acceso libre, con las instrucciones de administración y puntuación completas. No se identificó restricción de licencia comercial; se recomienda citar a los autores originales. Verificar condiciones de reproducción de la traducción al español (fuente y autoría de la traducción no identificadas) antes de cualquier uso o redistribución — no verificado.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Carver, C. S., Pozo-Kaderman, C., Price, A. A., Noriega, V., Harris, S. D., Derhagopian, R. P., Robinson, D. S., & Moffatt, F. L. Jr. (1998). Concern about aspects of body image and adjustment to early stage breast cancer. *Psychosomatic Medicine*, 60, 168-174.

Petronis, V. M., Carver, C. S., Antoni, M. H., & Weiss, S. (2003). Investment in body image and psychosocial well-being among women treated for early stage breast cancer: Partial replication and extension. *Psychology and Health*, 18, 1-13.

Fuente oficial de administración y puntuación:

<https://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/mba.html> (página institucional de Charles S. Carver, University of Miami, leída íntegramente durante esta verificación).